



L'unicità della Sardegna

La Sardegna, al pari di altre isole, è da sempre nel mirino della ricerca genetica. “Alcune varianti genetiche particolarmente frequenti in Sardegna sono rare o assenti in altre popolazioni, mentre altre varianti comuni al di fuori della Sardegna sono rare nell'isola – spiega Roberta Piras -

Queste caratteristiche peculiari si spiegano solo attraverso un lungo isolamento plurimillenario rispetto alle altre popolazioni. Mutazioni che sono sorte in tempi antichi e che sono state trasmesse ai discendenti possono essere trovate oggi in famiglie apparentemente non relazionate tra loro con una frequenza più alta rispetto al resto della popolazione. E questo si manifesta con una più alta incidenza di malattie genetiche rare”.

Lo screening genetico

“Abbiamo inizialmente condotto uno studio pilota per stabilire la frequenza delle due mutazioni più frequenti trovate associate con la sindrome di Crisponi in Sardegna. Questo ci ha permesso di stimare la frequenza dei portatori sani e di determinare l'incidenza della sindrome nell'isola. I risultati ottenuti indicano una percentuale di portatori dell'1,4% con un'incidenza di circa un affetto su 20.700 nuovi nati, di cui 15.000 nati vivi in un anno. Numeri che confermano approssimativamente i dati epidemiologici raccolti in questi ultimi 40 anni in Sardegna durante i quali sono stati identificati 24 pazienti (nove attualmente viventi più 15 deceduti prima del 2007)”.

Lo screening genetico, tuttavia, non può essere di massa. “La sindrome di Crisponi – conclude la Dott.ssa Piras - nonostante sia maggiormente diffusa in quest'isola, rimane pur sempre una patologia rara e i dati ottenuti finora non giustificano l'estensione dello screening a tutte le coppie in età fertile, ma solo alle coppie a rischio per storia familiare della malattia. Ovvero coppie nelle quali entrambi i membri siano portatori e pertanto a rischio di generare figli malati nel 25% dei casi.



L'identificazione dello stato di portatore rappresenta un grosso passo avanti nella prevenzione: induce innanzitutto a valutare il rischio di concepire figli malati e, attraverso una diagnosi prenatale, può portare all'individuazione precoce dello stato di malattia e quindi anche ad una riduzione della mortalità neonatale grazie all'attuazione di provvedimenti preventivi che permettano di alleviare il decorso clinico della patologia”.

Squadra Sky di Una Partita per Tany 2008



Farfalla e Tartaruga ringraziano:

I medici I Ricercatori I pazienti ma soprattutto tutti i farfallonari e sostenitori che con il loro costante sostegno consentono ai lavori di ricerca di proseguire

Un grazie anche a:
La rivista Galileo per l'autorizzazione alla reimpaginazione e stampa dell'articolo.



Sindrome di Crisponi: La ricerca parla italiano di Daniela De Vecchis

pubblicato il 23 Settembre 2013

Quei visini paffutelli, deturpati dal pianto come da spasmi, hanno fatto la loro comparsa per la prima volta negli anni Settanta all'Ospedale di Cagliari. Tra la meraviglia e l'impotenza struggente di medici e genitori. Impossibile consolarli nel modo che sarebbe più naturale e più a portata di neonato, offrendogli cioè il seno della mamma come anche un biberon, perché non riescono né a succhiare né a deglutire. Inarrestabile quella saliva che sembra scendere all'infinito. Insensibile a tutti gli antipiretici conosciuti quella febbre strana, con picchi, a volte, fatali. Ci sono voluti più di 20 anni per mettere ordine tra i segni e i sintomi di una malattia sconosciuta, descriverla su una rivista internazionale e finalmente chiamarla per nome: sindrome di Crisponi (CS).



E' Giorgiorgio Crisponi, infatti, il pediatra che dopo aver osservato la patologia in 17 pazienti provenienti da 12 famiglie del centro/sud della Sardegna, nel 1996, per primo, ne ha descritto il fenotipo, ossia tutti quei segni caratteristici presenti fin dalla nascita: viso largo con guance paffute, nasino ampio con narici anteverse, deformazione delle dita di tutte e due le mani, a volte dei piedi, e quelle immancabili, marcate contrazioni dei muscoli facciali – fino a rendere difficile o impossibile aprire la bocca - in risposta a stimoli tattili o durante il pianto, con abbondante salivazione. “Da qui, un decorso clinico caratterizzato da difficoltà nell'alimentazione per assenza del riflesso di suzione e deglutizione che richiede l'utilizzo di un sondino nasogastrico -



racconta Laura Crisponi, ricercatrice presso l'Istituto di ricerca genetica e biomedica del Cnr di Cagliari, dove porta avanti il lavoro del padre - I piccoli inoltre vanno incontro a crisi di ipertermia, con irregolari picchi febbrili che superano i 42°C, e che spesso conducono alla morte”. Ed è proprio quella colonnina di mercurio che per giorni e giorni tocca temperature elevate fino a raggiungere anche il massimo e oltre, il vero tormento di questi bambini. Caldi, a volte bollenti. A niente o a poco servono farmaci e bagnetti di acqua fredda; gli spostamenti, anche brevi, in alcuni casi indispensabili (in ospedale per esempio) diventano pericolosi; impossibile la permanenza in ambienti non refrigerati poiché è sufficiente una temperatura superiore a 22°C per scatenare la febbre; vietata, ovviamente, la spiaggia d'estate.

Eppure, nonostante la prognosi così severa, la sopravvivenza è possibile. “La maggior parte dei problemi legati alla prima infanzia (l'ipertermia, la difficoltà nell'alimentazione, la contrattura nel pianto) in genere scompare nel corso dei primi due anni di vita. Tuttavia ne insorgono altri. Già alla fine del primo anno, i piccoli pazienti presentano una scoliosi che si accentua con l'età e nonostante l'uso di corsetti correttivi evolve verso una severa cifoscoliosi toracolombare che richiede il ricorso all'intervento chirurgico.

